针灸辅助语言训练对脑卒中失语症患者语言功能及神经功能的影响

韩刚，韩苏娟 *
（宝鸡第三医院，陕西 宝鸡，721000）

摘要：**目的** 分析针灸辅助语言训练对脑卒中失语症患者语言功能及神经功能的影响。**方法** 选取 2021 年 6 月至2022 年 6 月我院收治的 80 例脑卒中失语症患者作为研究对象，按随机数字表法将其分为对照组和观察组，各 40 例。两组均行基础治疗和常规康复训练，在此基础上，对照组给予语言训练，观察组实施针灸辅助语言训练。比较两组的治疗效果。**结果** 治疗后，观察组的汉语失语成套测验（ABC）各维度评分及总分高于对照组，美国国立卫生研究院卒中量表（NIHSS）评分低于对照组（$P<0.05$）。随访时，观察组的中国式功能性语言沟通能力检测法（CFCP）各维度评分及总分高于对照组，脑卒中影响量表（SIS）各维度评分高于对照组（$P<0.05$）。**结论** 脑卒中失语症患者实施针灸辅助语言训练不仅能够有效改善患者的神经功能、语言功能，还能提高患者的生活质量。

关键词：脑卒中；失语症；语言训练；针灸；语言功能；神经功能
中图分类号：R246.6　　文献标志码：A　　文章编号：2096-1413(2024)32-0143-04

Effects of acupuncture-assisted language training on language function and neurological function in patients with stroke aphasia

HAN Gang, HAN Sujuan *
(Baoji Third Hospital, Baoji 721000, China)

ABSTRACT: ***Objective*** To analyze the effects of acupuncture-assisted language training on language function and neurological function in patients with stroke aphasia. ***Methods*** A total of 80 patients with stroke aphasia admitted in our hospital from June 2021 to June 2022 were selected as the research objects and divided into control group and observation group according to the random number table method, with 40 cases in each group. Both groups were given basic treatment and routine rehabilitation training. On this basis, the control group was given language training, and the observation group was given acupuncture-assisted language training. The therapeutic effects of the two groups were compared. ***Results*** After treatment, the scores of each dimension and total score of Aphasia Battery of Chinese (ABC) in the observation group were higher than those in the control group, while the National Institutes of Heahh Stroke Scale (NIHSS) score was lower than that of the control group ($P<0.05$). At follow-up, the scores of each dimension and total score of Chinese Functional Communication Profile (CFCP) in the observation group were higher than those in the control group, and the scores of each dimension of Stroke Impact Scale (SIS) were higher than those in the control group ($P<0.05$). ***Conclusion*** The implementation of acupuncture-assisted language training in patients with stroke aphasia can not only effectively improve the neurological function and language function of patients, but also elevate the quality of life of patients.

KEYWORDS: stroke; aphasia; language training; acupuncture; language function; neurological function

脑卒中是临床常见疾病，指多种原因导致脑血管受损，脑组织、细胞坏死。脑卒中患者由于脑供血区受损，往往存在不同程度的功能障碍，失语症是常见的并发症之一。有报道称，我国脑卒中患者中约 35% 伴有失语症，严重影响其生活质量[1-2]。脑卒中失语症患者表现为表达困难、沟通障碍、无法理解语言和符号、无法书写、阅读等。临床上主要通过语言训练来促使患者语言功能恢复，但语言训练存在训练时间长、见效慢等不足，长时间训练效果不理想容易导致患者产生消极的心理，从而降低依从性，影响训练效果[3-4]。随着对脑卒中失语症研究的深入，发现中医针灸通过刺激穴位可疏经通络，醒脑开窍，改善血

DOI：10.19347/j.cnki.2096-1413.202432036
作者简介：韩刚（1984— ），男，主治医师，学士。研究方向：脑卒中后康复。
* 通讯作者：韩苏娟，E-mail:15191793357@163.com.

中国知网 https://www.cnki.net

液循环，从而促进语言功能恢复[5]。但目前在脑卒中失语症中的应用研究较少。基于此，本研究就单一语言训练、针灸辅助语言训练治疗脑卒中失语症患者的临床效果展开比较，具体内容报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取 2021 年 6 月至 2022 年 6 月我院收治的 80 例脑卒中失语症患者作为研究对象，按随机数字表法将其分为对照组和观察组，各 40 例。对照组男 22 例，女 18 例；年龄 43~75 岁，平均年龄（59.11±6.86）岁；病程 5~50 d，平均（27.51±5.94）d；波士顿诊断性失语症测验（Boston Diagnostic Aphasia Examination, BDAE）评级：Ⅰ级 15 例，Ⅱ级 21 例，Ⅲ级 4例。观察组男 20 例，女 20 例；年龄 42~73 岁，平均年龄（58.87±6.59）岁；病程 6~48 d，平均（26.71±5.37）d；BDAE 评级：Ⅰ级 16 例，Ⅱ级 19 例，Ⅲ级 5例。两组患者的一般资料比较，差异无统计学意义（P>0.05）。本院医学伦理会审批通过此次研究；患者均签署知情同意书。

纳入标准：①符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018》[6]中脑卒中的诊断标准，并经头颅 CT、MRI 等检查确诊；②符合失语症诊断标准[7]；③首次发病及治疗；④临床资料完整。排除标准：①合并重要脏器功能不全；②合并精神疾病、意识障碍；③合并恶性肿瘤；④其他原因导致的语言障碍；⑤依从性低、不配合；⑥中途退出研究。

1.2 方法

两组患者均行基础治疗和常规康复训练。基础治疗包括基础疾病治疗、抗血小板聚集、维持水电解质平衡等。常规康复训练包括体能训练和日常训练。在此基础上，对照组给予语言训练，包括发音器官训练、阅读训练、发音训练、写字训练等，具体内容如下。①发音器官训练：指导患者反复做嘴唇前突、缩回、张口、闭口、舌头伸出、舌头缩回动作，5 min/次，3次/d。指导患者做舌尖反复舔两侧唇角、舌尖绕唇运动、上下唇碰撞等动作，5 min/次，3 次/d。指导患者反复做鼓腮、龇牙、噘嘴、吹口哨、吹蜡烛等动作，5 min/次，3 次/d。②阅读训练：准备一些色卡、图片等让患者辨认，训练其辨别能力。准备文字卡片，让患者通过排序形成通顺的句子。给患者一些简单的短文，引导其跟读，鼓励自行阅读，并在完成跟读或阅读后提出问题，让患者回答，1 篇/次，3次/d。③发音训练：先从汉语拼音的音节表进行练习，先学元音字母，再到喉音、唇音、舌齿音等。患者掌握音节练习后，再指导其练习简单的日常生活用语、短句，发音训练需反复练习，循序渐进，10 min/次，3 次/d。④写字训练：首先训练握笔能力，让患者书写简单的数字、汉字，再逐渐增加书写难度，即单字、组词、句子、短文，书写训练 10 min/次，3 次/d。

观察组实施针灸辅助语言训练，语言训练方法同对照组，针灸具体操作如下。根据患者的失语症情况取头针，感觉性失语患者则取感觉区、运动性失语患者则取运动区、完全性失语患者则取语言三区，再联合曲池穴、足三里穴、内关穴等作为辅助穴位。患者取仰卧位，常规消毒局部皮肤，采用华佗牌 26~28 号不锈钢毫针沿头皮以 30°刺入，约为 3~5 cm，到帽状腱膜下层为止，固定，快速捻转行针 1 min，捻转约 300 次，隔 10 min 后，再快速捻转 2 min。体针则采用平补平泻法进针，约为 3~8 cm，得气后留针 30 min，起针后用无菌干棉球按压针眼 1 min，无出血后即可，1 次/d，6 次/周。

两组均连续治疗 8 周，并进行为期 3 个月的随访。

1.3 观察指标及评价标准

⑴ 语言功能恢复情况。分别在治疗前、后采用汉语失语成套测验（Aphasia Battery of Chinese, ABC）评估患者的语言功能恢复情况，共包含 9 个项目，考虑到患者文化水平不一致，仅进行 4 项测验，包括自发语言、听理解、命名、复述，每项 25 分，得分越高则表示患者的语言功能恢复越好[8]。

⑵ 神经功能。分别在治疗前、后采用美国国立卫生研究院卒中量表（National Institutes of Heahh Stroke Scale, NIHSS）评估患者的神经功能，总分 0~42 分，得分越低则表示患者的神经功能损伤越轻[9]。

⑶ 日常沟通能力。分别在治疗前、随访时采用中国式功能性语言沟通能力检测法（Chinese Functional Communication Profile, CFCP）评估患者的日常沟通能力，包括理解（100 分）、说（50 分）、写（40 分）、读（20 分）、其他（40 分）5 个维度，总分 0~250 分，得分越高则表示患者的日常沟通能力越好[10]。

⑷ 生活质量。分别在治疗前、随访时采用脑卒中影响量表（Stroke Impact Scale, SIS）评估患者的生活质量，包括记忆与思维、交流、情绪、患侧手功能、日常生活能力、移动能力、力气、社会参与 8 个维度，每个维度为 0~100 分，分值越高则表示患者的生活质量越好[11]。

1.4 统计学方法

采用 SPSS22.0 统计学软件处理数据，计数资料用 n/%表示，行 χ^2 检验，计量资料用 $\bar{x}\pm s$ 表示，行 t 检验，以 P<0.05 为差异具有统计学意义。

中国知网 https://www.cnki.net

2 结果

2.1 两组患者治疗前、后的语言功能恢复情况比较

治疗后，观察组的 ABC 各维度评分及总分高于对照组（$P<0.05$，表 1）。

2.2 两组患者治疗前、后的神经功能比较

治疗后，观察组的 NIHSS 评分显著低于对照组（$P<0.05$，表 2）。

表 1　两组患者治疗前、后的语言功能恢复情况比较（n=40，$\bar{x}\pm s$，分）

组别	时间	自发语言	听理解	命名	复述	总分
观察组	治疗前	15.64±3.49	15.69±3.74	15.29±3.66	15.45±3.78	62.07±6.73
	治疗后	21.57±2.35*	21.33±2.19*	21.12±2.28*	21.66±2.49*	85.68±8.21*
	t	8.914	8.230	8.551	8.677	14.066
	P	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
对照组	治疗前	15.52±3.55	15.88±3.52	15.35±3.77	15.43±3.18	62.18±6.82
	治疗后	19.68±3.16	19.36±3.37	19.74±3.51	19.49±3.73	78.27±8.19
	t	5.536	4.516	5.390	5.238	9.548
	P	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

注：与对照组治疗后比较，*$P<0.05$。

表 2　两组患者治疗前、后的神经功能比较（n=40，$\bar{x}\pm s$，分）

组别	治疗前	治疗后	t	P
观察组	30.87±5.85	15.59±3.11	14.586	<0.001
对照组	30.69±5.42	20.46±3.85	9.732	<0.001
t	0.143	6.223		
P	0.887	<0.001		

2.3 两组患者治疗前、随访时的日常沟通能力比较

随访时，观察组的 CFCP 各维度评分及总分高于对照组（$P<0.05$，表 3）。

2.4 两组患者治疗前、随访时的生活质量比较

随访时，观察组的 SIS 各维度评分高于对照组（$P<0.05$，表 4）。

表 3　两组患者治疗前、随访时的日常沟通能力比较（n=40，$\bar{x}\pm s$，分）

组别	时间	理解	说	写	读	其他	总分
观察组	治疗前	30.03±5.92	20.56±4.78	20.11±4.83	10.39±2.84	20.27±4.85	101.36±25.86
	随访时	80.58±8.16*	41.66±5.25*	35.63±4.22*	16.57±3.26*	35.59±4.31*	210.31±40.12*
	t	16.593	10.810	18.266	18.125	17.335	25.883
	P	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
对照组	治疗前	30.39±5.86	20.61±4.59	20.14±4.18	10.27±2.63	20.34±4.92	101.75±25.33
	随访时	60.21±6.15	30.26±5.38	28.54±4.41	13.25±3.49	28.14±4.51	160.41±40.72
	t	13.620	14.132	10.423	11.942	11.423	19.905
	P	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

注：与对照组随访时比较，*$P<0.05$。

表 4　两组患者治疗前、随访时的生活质量比较（n=40，$\bar{x}\pm s$，分）

组别	时间	记忆与思维	交流	情绪	患侧手功能	日常生活能力	移动能力	力气	社会参与
观察组	治疗前	50.70±6.66	51.65±6.73	48.88±6.62	45.86±7.52	51.75±8.71	51.69±8.58	56.86±6.59	55.68±6.52
	随访时	82.69±10.21*	80.64±8.23*	83.71±10.26*	80.65±8.19*	83.75±10.16*	83.66±10.21*	84.73±8.24*	80.57±10.31*
	t	11.391	13.742	15.856	15.841	15.948	13.954	11.441	14.675
	P	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
对照组	治疗前	51.68±6.71	50.95±6.82	49.51±6.46	46.88±7.47	50.76±8.63	50.71±8.74	55.84±6.65	54.48±6.33
	随访时	70.52±10.44	71.48±8.39	72.15±9.47	70.32±8.51	71.45±9.55	72.62±10.34	73.88±7.27	70.61±10.35
	t	7.240	11.609	12.946	8.015	9.932	8.406	6.598	9.442
	P	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

注：与对照组随访时比较，*$P<0.05$。

3 讨论

近年来，随着我国人口老龄化程度加剧，脑卒中发病率逐年增多。虽然医疗水平提升在一定程度上降低了脑卒中的死亡率，但致残率仍居高不下，尤其是语言功能障碍。脑卒中失语症严重影响患者的日

中国知网　https://www.cnki.net

常沟通，由于康复训练时间长、起效慢，常规训练效果并不理想。因此，修复神经损伤、重建语言功能，促进语言功能恢复对于提升脑卒中失语症患者的生活质量有重要意义。临床上主要通过语言训练来改善患者发音、语言、理解、阅读、书写等能力，在一定程度上提升了脑卒中失语症患者的语言功能，但因训练时间长、效果慢，很多患者难以坚持，整体效果不佳。随着中医学的发展，中医针灸在临床的应用越来越广泛。针灸用于脑卒中失语症患者中，通过直接刺激患者头部相关穴位来促进血液循环，促使神经再生，修复组织损伤，有利于帮助患者恢复[12]。

中医认为脑卒中失语症属于“中风”“不语”“风喑”等范畴，病机为痰浊阻滞、气血逆乱、正气虚弱、阴阳失调等，因此，治疗上要以醒脑开窍、疏经通络为主。针灸具有通络、止痛、散瘀、活血等作用，持续刺激相关穴位可增强、重建脑卒中的中枢神经，修复神经损伤，从而促进神经功能、语言功能恢复。语言训练是反复对发音器官、唇部、舌部等进行训练，提升软腭灵活度，促进语言功能恢复。本研究经过 8周的治疗，结果显示，观察组的 ABC 各维度评分及总分高于对照组，NIHSS 评分低于对照组，差异具有统计学意义（$P<0.05$），说明针灸辅助语言训练可有效改善脑卒中失语症患者的语言功能和神经功能。本研究针灸取头针，再根据患者的具体情况分别取感觉区、运动区、语言三区，再配合曲池穴、足三里穴、内关穴等，有效刺激穴位、经络，达到活血行气、醒脑开窍的效果，从而有效改善脑组织血供，有利于言语功能恢复。中医有“头者精明之府”的理论，因而针灸治疗脑卒中失语症患者首选头皮特定刺激区。现代医学研究发现，针刺脑卒中患者头部穴位可改善血液循环，缓解血管痉挛，保护神经细胞形态，修复脑组织损伤。语言训练通过对患者进行反复的发音器官训练、发音训练、阅读训练、写字训练，从而有效唤醒语言系统，促进患者语言功能恢复[13]。有研究证实，针灸与语言康复训练联合用于脑卒中失语症患者中可起到增强协同作用，有效促进气血运行，修复受损神经细胞，从而改善神经功能和语言功能[14]，与本研究结果具有一致性。

脑卒中失语症患者因语言功能障碍增加了日常沟通难度，从而影响生活质量。本研究治疗后经过3个月的随访，结果发现，观察组的日常沟通能力及生活质量评分均高于对照组（$P<0.05$），说明针灸辅助语言训练可有效提高脑卒中失语症患者的沟通能力和生活质量。本研究语言训练中，通过发音器官训练，发音、书写、阅读从易到难的反复训练来有效刺激损伤的大脑语言中枢，有利于残存功能恢复，促进语言功能恢复，从而有效提高日常沟通能力。有学者认为，脑卒中失语症患者通过针灸刺激头部相关穴位，可起到疏通经络、改善循环、修复组织损伤等作用，同时开展语言康复训练，可进一步提高语言功能恢复效果[15]。

综上所述，针灸辅助语言训练应用于脑卒中失语症患者中可起到协同增效的作用，不仅能够有效促进患者的神经功能、语言功能恢复，还能有效提高日常沟通能力和生活质量，具有重要的应用价值。

参考文献：

[1] 于燕.缺血性脑卒中后失语症发病及恢复机制研究进展[J].医学理论与实践,2018,31(10):1425-1426,1433.
[2] 邓北珍,张波,杨柳.脑卒中后失语症患者认知障碍的影响因素分析[J].中国听力语言康复科学杂志,2019,17(2):96-98.
[3] 秦祖杰.早期语言康复训练对急性脑卒中后失语症患者的影响[J].中国医药指南,2019,17(14):191-192.
[4] DENG SZ,SANG BM,LI BX,et al.The efficacy and safety of acupuncture combined with language training for motor aphasia after stroke: study protocol for a multicenter randomized sham-controlled trial[J].Trials,2022,23(1):540.
[5] 卓碧芳,张梦龙,秦晨阳,等.针刺治疗中风后失语症的研究进展[J].中医药学报,2022,50(1):41-46.
[6] 中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018[J].中华神经科杂志,2018,51(9):666-682.
[7] 高素荣.失语症[M].2 版.北京:北京大学医学出版社,2006:1.
[8] 孙平秀,姚滔涛,许铛瀚.醒脑开喑针法联合经颅磁刺激治疗亚急性期卒中后非流利性失语的临床观察[J].中国中医急症,2024,33(2):302-305.
[9] FINOCCHI C,BALESTRINO M,MALFATTO L,et al.National Institutes of Health Stroke Scale in patients with primary intracerebral hemorrhage[J].Neurol Sci,2018,39(10):1751-1755.
[10] 席娜.醒脑开窍针刺法结合语言康复训练治疗脑梗死运动性失语效果[J].中医临床研究,2020,12(10):47-49.
[11] 郑智慧,黄钰峰,陈芬芳,等.气功呵字诀对缺血性脑卒中病人左心功能及生活质量的影响[J].护理研究,2023,37(23):4314-4320.
[12] 李小霞,张莹莹.针药联合言语康复训练治疗脑卒中后失语症患者的疗效探究[J].实用中西医结合临床,2021,21(14):47-48.
[13] 陈秋红,刘亮,诸懿,等.头针疗法联合言语康复训练对脑卒中后失语症患者语言功能康复及生活质量的影响[J].现代中西医结合杂志,2019,28(10):1032-1035,1064.
[14] 陈玲莉,林婉卿,李秀宇,等.针灸联合康复治疗对脑卒中后运动性失语症患者语言功能的作用研究[J].深圳中西医结合杂志,2022,32(12):10-14.
[15] 赵德福,赵瑜,杨孝芳.督脉取穴针刺联合 Schuell 语言康复训练对脑卒中后失语症患者言语功能、MoCA 评分及语言中枢活动功能的影响[J].临床和实验医学杂志,2021,20(8):886-890.

中国知网 https://www.cnki.net